proregen

GUIA PARA PACIENTES

Dor no quadril: entender para cuidar melhor

Artrose do quadril e dor na lateral do quadril são problemas diferentes. Este guia explica cada um, o que se sabe sobre o tratamento e o que ainda está em pesquisa. Com honestidade, sem promessas.

Conteúdo educativo. Não substitui a consulta médica.
Baseado em estudos científicos publicados até novembro de 2026.

EDIÇÃO 2026

ANTES DE COMEÇAR

Nem toda dor no quadril é a mesma coisa

Muita gente chama de "dor no quadril" qualquer dor entre a virilha, a nádega e a lateral da coxa. Mas, por trás dessa dor, podem estar problemas bem diferentes, com causas e tratamentos diferentes.

Artrose do quadril

Desgaste da **cartilagem**, a camada lisa que reveste a articulação entre a bacia e o fêmur. A dor costuma aparecer na **virilha** e pode descer para a coxa ou o joelho.

Dor na lateral do quadril

Muitas vezes vem dos **tendões dos glúteos** (glúteo médio e mínimo), que se prendem num ponto ósseo na lateral da coxa. É a chamada **tendinopatia glútea**. Não é artrose.

POR QUE ISSO IMPORTA

Uma pessoa pode ter os dois problemas ao mesmo tempo, ou só um deles. Por isso a avaliação médica, com exame físico e, quando necessário, exames de imagem, é o primeiro passo.

01	Artrose do quadril	3
02	Dor na lateral do quadril (tendinopatia glútea)	4
03	A base do tratamento	5
04	PRP no quadril: em pesquisa	6
05	Sinais de alerta e perguntas frequentes	7
06	Referências e contato	8

Quando a cartilagem se desgasta

A artrose é comum com o passar dos anos, mas não é "coisa da idade" sem solução. Há muito a fazer para aliviar a dor e manter você ativo.

O que você pode sentir

Dor na virilha ao caminhar, subir escadas ou levantar da cadeira. Rigidez de manhã ou depois de ficar parado. Dificuldade para calçar meias, cortar as unhas dos pés ou entrar no carro.

O que aumenta o risco

Idade, histórico na família, alterações no formato do quadril desde a juventude, lesões antigas e excesso de peso.

Como é feito o diagnóstico

Pela conversa, pelo exame do movimento do quadril e por uma **radiografia** (raio X). A ressonância é pedida só em alguns casos.

O que a artrose não é

Não é uma sentença de cadeira de rodas. A evolução é diferente em cada pessoa, e muitos convivem bem com ela por anos, com o tratamento certo.

EM RESUMO

A artrose do quadril é um problema da **articulação**. O tratamento busca aliviar a dor, melhorar o movimento e a força, e adiar ou evitar a cirurgia quando possível. Nos casos avançados, a prótese de quadril é uma opção consolidada.

Os tendões dos glúteos

É uma das causas mais comuns de dor na lateral do quadril, sobretudo em mulheres acima dos 40 anos. Durante muito tempo foi chamada de "bursite trocantérica".

O que você pode sentir

Dor na parte de fora do quadril, que pode irradiar pela lateral da coxa. Piora ao **deitar de lado** à noite, subir escadas, ficar muito tempo em pé sobre uma perna ou **cruzar as pernas**.

Por que acontece

Os tendões sofrem com sobrecarga repetida ou compressão. Mudanças bruscas de atividade, fraqueza dos glúteos e excesso de peso costumam contribuir.

Como é feito o diagnóstico

Pelo exame físico, com testes de dor ao apertar e ao contrair os glúteos. O **ultrassom** ou a ressonância ajudam a ver o tendão e descartar rupturas.

Diferente da artrose

Aqui o problema está no **tendão**, fora da articulação. O tratamento também é diferente.

> DICA DO DIA A DIA
>
> Evite cruzar as pernas e dormir sobre o lado dolorido. Ao deitar do outro lado, um travesseiro entre os joelhos alivia a pressão no tendão.

O que vem em primeiro lugar

Nos dois problemas, o tratamento começa por medidas simples, que têm o melhor respaldo científico. Elas são a base de qualquer plano.

1

Exercício orientado

Fortalecer os glúteos e as coxas e manter o quadril em movimento. Na tendinopatia glútea, exercícios específicos, com carga progressiva, são o pilar do tratamento. Um fisioterapeuta ou profissional de educação física pode guiar você.

2

Controle do peso

Cada quilo a menos reduz a carga sobre a articulação e os tendões a cada passo.

3

Ajustar a carga, sem parar de vez

Reduzir temporariamente o que provoca dor, sem abandonar a atividade. Repouso total costuma piorar a rigidez e a fraqueza.

4

Remédios, com orientação

Analgésicos e anti-inflamatórios podem ajudar em períodos de crise, sempre prescritos pelo médico, por causa dos efeitos no estômago, nos rins e no coração.

5

Infiltrações e cirurgia, quando indicadas

Infiltrações podem aliviar a dor em casos selecionados. Na artrose avançada, a prótese de quadril é uma opção consolidada. A indicação depende da avaliação individual.

O QUE ESPERAR

A melhora costuma ser gradual, ao longo de semanas. O resultado varia de pessoa para pessoa e nenhum tratamento pode ser garantido.

PRP no quadril: o que dá para dizer hoje

Talvez você já tenha ouvido falar em tratamento "com o próprio sangue". É o **PRP**, plasma rico em plaquetas.

O que é o PRP

As plaquetas são pequenas partes do sangue que ajudam a estancar sangramentos e liberam substâncias que sinalizam reparo. No PRP, elas são concentradas a partir de uma pequena amostra do **seu próprio sangue**.

O PRP é um procedimento médico auxiliar e complementar: não substitui o tratamento clínico, a reabilitação ou a cirurgia indicada.

A regra do Conselho Federal de Medicina

A **Resolução CFM nº 2.464/2026** autoriza o uso do PRP, como procedimento auxiliar, em quatro situações: artrose do joelho, disco da coluna lombar, cotovelo de tenista e reparo do menisco.

O quadril **não está** entre elas.

EM PESQUISA, FORA DAS INDICAÇÕES AUTORIZADAS PELO CFM

Artrose do quadril (PRP sozinho ou combinado com ácido hialurônico) e tendinopatia dos glúteos.

Existem estudos científicos sobre esses usos, alguns listados nas referências deste guia. Mas, pelas regras atuais, eles seguem no campo da pesquisa e não são oferecidos como tratamento de rotina.

NA PRÁTICA

Se você tem dor no quadril, a consulta serve para entender a causa e montar um plano com as opções reconhecidas. Se no futuro as regras mudarem, as recomendações deste guia serão atualizadas.

Quando procurar ajuda logo

- Dor forte após queda, com dificuldade para apoiar a perna.
- Febre, vermelhidão ou calor intenso no quadril.
- Dor que acorda você todas as noites e não alivia com repouso.
- Perda de peso sem explicação ou formigamento e fraqueza na perna.

P Dor na virilha é sempre artrose?

Não. Pode vir da articulação do quadril, mas também de hérnias, da coluna ou de outras estruturas. Por isso a avaliação é importante.

P A dor na lateral do quadril vira artrose?

São problemas diferentes. A tendinopatia glútea está no tendão, fora da articulação. Uma pessoa pode ter os dois, mas um não se transforma no outro.

P Posso continuar caminhando?

Na maioria dos casos, sim, ajustando a distância e o ritmo. Manter-se ativo faz parte do tratamento.

P Vou precisar de prótese?

Nem sempre. A prótese é uma opção para a artrose avançada que limita muito a vida, depois de avaliação individual.

P Posso fazer PRP no quadril?

Hoje o uso no quadril é considerado em pesquisa e está fora das indicações autorizadas pelo CFM. Na consulta, conversamos sobre as opções reconhecidas para o seu caso.

QUER CONVERSAR SOBRE O SEU CASO?

Agende uma avaliação com o Dr. André Kruel, presencial em Bento Gonçalves (RS) ou por consulta online. WhatsApp (54) 99689-1295 · proregen.com.br

De onde vêm estas informações

Os estudos abaixo tratam de usos do PRP no quadril que seguem em pesquisa, fora das indicações autorizadas pelo CFM. Estão listados para transparência, não como recomendação de tratamento.

1. Fitzpatrick J, Bulsara MK, O'Donnell J, Zheng MH. Leucocyte-rich platelet-rich plasma treatment of gluteus medius and minimus tendinopathy: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med. 2019;47(5):1130-1137. doi:10.1177/0363546519826969.
2. Nouri F, Babaee M, Peydayesh P, Esmaily H, Raeissadat SA. Comparison between the effects of ultrasound guided intra-articular injections of PRP, high molecular weight hyaluronic acid, and their combination in hip osteoarthritis: a randomized clinical trial. BMC Musculoskelet Disord. 2022;23:856. doi:10.1186/s12891-022-05787-8.
3. Dallari D, Stagni C, Rani N, et al. Ultrasound-guided injection of platelet-rich plasma and hyaluronic acid, separately and in combination, for hip osteoarthritis: a randomized controlled study. Am J Sports Med. 2016;44(3):664-671. doi:10.1177/0363546515620383.
4. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.464, de 2 de julho de 2026. DOU 15/07/2026, Seção 1, p. 70.

Responsável técnico

Dr. André Kruel · Médico ortopedista

CRM-RS 23627 · RQE 14323

Contato

Proregen · Bento Gonçalves (RS) e consulta online

WhatsApp (54) 99689-1295 · proregen.com.br

Material educativo. Não substitui a consulta médica. Não contém preços, imagens de "antes e depois" ou depoimentos, conforme as regras de publicidade médica do CFM. Edição novembro de 2026.

proregen